



DATOS DEL PACIENTE

Paciente	García Martínez, Carlos	Fecha de nacimiento	25/09/1970 (53 años)
Domicilio	Calle Mayor 8, 4.º B, 28013 Madrid, Comunidad de Madrid	DNI / SIP	45678901X / SIP-MAD-2024-77532
N.º Historia Clínica	HUP-2024-445219	Médico responsable	Dra. Rosa Fernández Jiménez, Especialista en Med. Interna
Fecha de visita	21/09/2024 (Consulta ambulatoria)	Seguro médico	MUFACE — Póliza n.º MUF-2024-ES-00882

1 — MOTIVO DE CONSULTA Y SÍNTOMAS ACTUALES

El paciente refiere astenia progresiva de 8 semanas de evolución, pérdida de peso no intencionada de aproximadamente 7 kg en 2 meses, sudoración nocturna profusa y episodios febriles vespertinos (picos de 38,4–38,9 °C). Desde hace 3 semanas nota una masa indolora en la región cervical derecha. No refiere tos ni hemoptisis. Niega viajes recientes a zonas endémicas. Antecedentes personales relevantes: ex-fumador (15 paquetes-año, cese hace 5 años), sin alergias conocidas. Medicación actual: ninguna de forma regular.

2 — EXPLORACIÓN FÍSICA

Parámetro	Valor	Referencia
Temperatura	38,6 °C	36,1–37,2 °C
TA / FC	118/74 mmHg / 92/min	< 130/80 / 60–100/min
Peso / Talla / IMC	68 kg / 178 cm / 21,5	—
Adenopatías	Cervical derecha 3×2 cm, axilar bilateral < 1 cm	Ausentes
Hígado / Bazo	Hepatomegalia + 2 cm, esplenomegalia leve	No palpables
Auscultación	Murmullo vesicular conservado bilateral	Normal

3 — RESULTADOS ANALÍTICOS Y DE IMAGEN

Hemograma: Leucocitos $14,8 \times 10^9/L$ (linfocitosis relativa 58 %), Hemoglobina 10,2 g/dL (normocítica), Plaquetas $87 \times 10^9/L$. Bioquímica: LDH 842 U/L ($\uparrow \uparrow$), beta-2-microglobulina 4,6 mg/L ($\uparrow$), Ácido úrico 8,4 mg/dL, PCR 68 mg/L, VSG 94 mm/h. Frotis de sangre periférica: Presencia de linfocitos atípicos de gran tamaño. TC cuello/tórax/abdomen: Adenopatías cervicales, supraclaviculares, mediastínicas y paraaórticas. Esplenomegalia (17 cm). No ascitis. PET-TC: Captación intensa (SUVmáx 18) en adenopatías y bazo.

4 — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PROPUESTO

Primera hipótesis:

Linfoma de Hodgkin clásico (subtipo esclerosis nodular) — alta probabilidad dado el patrón de adenopatías, síntomas B y hallazgos PET.

Segunda hipótesis:

Linfoma no Hodgkin difuso de células B grandes (DLBCL) — a descartar por edad y LDH elevada.

Tercera hipótesis:	Tuberculosis ganglionar — menos probable dado ausencia de exposición y negatividad de mantoux (0 mm).
A descartar:	Carcinoma metastásico de origen desconocido, leucemia linfocítica crónica estadio avanzado.

5 — PLAN DIAGNÓSTICO Y SIGUIENTE PASO

Se solicita biopsia excisional de adenopatía cervical derecha con estudio anatomopatológico completo, inmunohistoquímica (CD15, CD30, CD20, BCL-2, Ki-67) y citogenética. Adicionalmente: biopsia de médula ósea bilateral, serologías (VIH, VEB, CMV, Toxoplasma), beta-HCG y AFP (para descartar tumor germinal). Derivación preferente a Hematología.

△ SYNTHETIC DOCUMENT — All patient data, names, identification numbers and clinical details in this document are entirely fictional and have been generated for AI research purposes. Any resemblance to real persons is purely coincidental. Not for clinical use.